

URTICARIA Y ANGIOEDEMA

Vanesa Gallego Fernández, María Fernández Mera, Antía Fernández Lorenzo, Francisco José Aramburu Vilariño, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La urticaria se define como la enfermedad caracterizada por el desarrollo de habones, angioedema o ambos.

Habón. El habón es una lesión máculo-papulosa eritematosa, con un halo pálido central de tamaño variable, con-fluente, de aparición súbita en minutos-horas y de resolución rápida (evanescentes), generalmente en menos de 24 horas. Suele asociar prurito. Se distribuyen de forma heterogénea por cualquier parte del cuerpo, siendo más frecuentes en tronco, cara y extremidades. Característicamente no dejan lesión residual, excepto las producidas por el rascado.

Angioedema. El angioedema, que afecta a dermis profunda y/o submucosa, se presenta como edema sin fovea, de márgenes imprecisos y sin eritema. Puede asociar dolor. A diferencia de otros edemas que suelen aparecer en zonas declives del cuerpo, en el angioedema se suelen afectar labios, lengua, párpados, genitales y vía aérea superior. El angioedema en ausencia de urticaria es infrecuente y obliga a descartar diagnósticos alternativos como angioedema hereditario o adquirido.

Un episodio de urticaria con o sin angioedema puede ocurrir en el 10-20% de la población general y hasta un 30% de los casos pueden evolucionar a la cronicidad. La incidencia es levemente superior en mujeres: 1,5/1. Actualmente la European Academy of Allergology and Clinical Immunology recomienda clasificar la urticaria en base a duración y factores implicados:

Urticaria aguda: menor o igual a seis semanas. Más común en niños y adultos jóvenes. Generalmente dependiente de IgE; relacionada con alimentos, parásitos, fármacos (penicilina, amiodarona, captopril, etc).

Urticaria crónica: mayor de 6 semanas. Más frecuente en adultos. Raras veces dependiente de IgE pero a menudo se debe a autoanticuerpos anti-FcεR; se desconoce la causa en el 80% de los casos.

- **Espontánea:** Aparición espontánea de habones, angioedema o ambos durante > 6 semanas debido a causas conocidas (p. ej. la presencia de autoanticuerpos activadores de mastocitos) o desconocidas.
- **Inducible:**
 - . **A frigore:** por objetos, fluidos o aire fríos.
 - . **Por presión:** presión vertical. Latencia de 3-12 horas.
 - . **Por calor:** calor localizado.
 - . **Solar:** exposición solar. Inicio inmediato.
 - . **Dermografismo (facticia):** inicio inmediato.
 - . **Vibratoria:** exposición cutánea a vibración, fricción y estiramiento repetido.
 - . **Acuagénica:** contacto con agua, independientemente de temperatura.

.Colinérgica: calor, ejercicio intenso, estrés.

.Contacto: agentes físicos, temperatura, estrés, etc.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la urticaria es fundamentalmente clínico (exhaustiva historia clínica), con la realización de escasas pruebas complementarias, más orientadas al tipo de urticaria y su desencadenante que al propio diagnóstico en sí. Las fases clásicas serían:

Anamnesis

Consiste en la realización de la historia clínica personal, que incluya:

- Antecedentes personales y familiares de urticaria y atopia (incluyendo alergias alimentarias).
- Antecedentes personales de otras enfermedades (infecciones, procesos inflamatorios, problemas digestivos, enfermedades psicosomáticas, estrés, implantes quirúrgicos), tratamientos previos y actuales (AI-NE, hormonas, laxantes, inmunizaciones...).
- Factores y posibles situaciones desencadenantes de los brotes que refiera el paciente: alimentos, medicamentos, estímulos físicos, síndrome menstrual...
- Sintomatología del paciente, que incluya los siguientes aspectos: habones (morfología, tamaño, localización y distribución), angioedema; asociación con prurito, dolor, quemazón...
- Frecuencia y duración de las lesiones, variación diurna, relación con vacaciones, viajes, etc.
- Sintomatología sistémica: cefalea, hipotensión, astenia, fiebre, artralgias, disnea, tos, dolor torácico...
- Hábitos tóxicos (alcohol, tabaco, otros) y ocupaciones (profesional, aficiones).

Exploración física

Se debe realizar una exploración física básica. Además, debe realizarse una visualización de toda la superficie cutánea donde existan lesiones, categorizando las mismas y ubicándolas, ya que la exploración física va dirigida fundamentalmente a identificar la lesión característica: el habón y el angioedema.

Pruebas complementarias

La urticaria aguda generalmente no requiere un estudio diagnóstico, ya que suele ser autolimitada.

La única excepción es la sospecha de urticaria aguda debido a una alergia alimentaria o a otros desencadenantes como los fármacos.

En el caso de la urticaria crónica, aunque son de escasa utilidad, sí se recomienda ampliar estudios con pruebas de laboratorio, habitualmente hemograma y PCR o VSG.

Únicamente si los hallazgos de la historia clínica y el examen físico son muy sugestivos, se podrían solicitar otras pruebas para la identificación de posibles factores desencadenantes: inmunoglobulina E (IgE) total, determinaciones microbiológicas (*Helicobacter pylori*, *Anisakis*), hormonas tiroideas, anticuerpos antitiroideos, anticuerpos antinucleares (ANA), test del suero autólogo (urticaria autoinmune), test de presión (urticaria por presión), test de cubo de hielo

(urticaria por frío), provocación con vórtex (urticaria vibratoria), test de provocación con ultravioleta (UV) (urticaria solar), dermatografómetro (dermografismo sintomático), contacto con gasa húmeda (urticaria acuagénica), ejercicio (urticaria colinérgica), test epicu-táneos (urticaria de contacto).

La biopsia cutánea no es necesaria en la mayoría de casos y debe considerarse solo ante sospecha de vasculitis, enfermedad autoinflamatoria u otra condición inmunológica que pueda presentarse con lesiones similares (penfigoide ampolloso, etc.).

Diagnóstico diferencial

Debemos realizar un diagnóstico diferencial a destacar:

- **Anafilaxia:** rápida progresión cutánea acompañada de afectación de otros órganos.
- **Toxicodermias:**

—**Inmediatas:** urticaria, progresión a anafilaxia.

—**Retardadas:** SSJ/NET (antecedente toma de fármacos 3-6 semanas; fiebre, erosiones en mucosas, lesiones ampollas; signo de Nikolsky positivo), DRESS (fiebre, adenopatías y afectación pulmonar, renal y hepática).

- **Urticaria-vaculitis:** lesiones habonosas más dolorosas que pruriginosas, con duración mayor de 24 horas, dejan lesión residual y no responden a tratamiento corticoideo. Asocian poliartralgias y fiebre.
- **Angioedema no histaminérgico (mediado por bradicininas):** angioedema sin afectación cutánea. Hereditario, adquirido o inducido por IECAS. No respuesta a tratamiento con anti-H1, corticoides o adrenalina.
- **Dermatitis de contacto:** local, no afectación generalizada. Exposición previa.
- **Alergia picaduras/alimentos:** exposición previa. Progresión anafilaxia.
- **Patología autoinmune tiroidea (enfermedad de Hashimoto):** edema palpebral/periorbicular sin afectación mucosa. Signos clínicos de patología tiroidea.
- **Eritema solar polimorfo:** eritema, pápulas, placas o vesículas pruriginosas en áreas fotoexpuestas. Inicio entre 30 minutos-6 horas tras exposición. Exposición solar previa.
- **Penfigoide ampolloso:** lesiones urticariformes, muy pruriginosas, que evolucionan a ampollas. Tronco y flexoras. Nikolsky negativo.

TRATAMIENTO

El tratamiento de la urticaria depende de la gravedad de la reacción y la rapidez de su evolución. La clínica asociados a tener en cuenta será:

- Signos y síntomas de rápida aparición o progresión.
- Dificultad respiratoria o distress respiratorio: taquipnea, hipoxemia hasta cianosis.
- Presencia de broncoespasmos (sibilancias).
- Disfonía/afonía, sialorrea y estridor por edema laríngeo.
- Puede presentar vómitos, hipotensión, confusión, somnolencia, síncope hasta el coma.

El tratamiento inicial de la urticaria aguda con o sin angioedema se debería enfocar en el alivio a corto plazo del prurito, de los habones y del angioedema si está presente. Aproximadamente dos tercios de los casos de urticaria aguda se resuelven espontáneamente.

Con respecto a la urticaria crónica, el enfoque terapéutico puede implicar la identificación y

eliminación de causas subyacentes, la evitación de factores desencadenantes, la inducción de tolerancia y/o el uso de tratamiento farmacológico para prevenir la liberación de los mediadores de mastocitos y/o los efectos de éstos.

Para eliminar la causa subyacente se necesita conocer cuál es dicha causa y esto no siempre es fácil.

En el caso de los fármacos, cuando se sospeche que son estos los causantes, deben de omitirse por completo o sustituirse por otra clase de fármacos si son imprescindibles.

Es aconsejable evitar los estímulos físicos para el tratamiento de las urticarias físicas y por presión, pero a veces también es complicado de lograr.

En cuanto al tratamiento farmacológico, en aquellos pacientes que sólo tienen síntomas cutáneos sin an-gioedema, los antihistamínicos orales suelen ser suficientes. En función de la gravedad o si se asocia angioedema se utilizarán también los glucocorticoides, a veces administrados por vía intravenosa.

En casos graves, con afectación respiratoria o cardiovascular, la prioridad es asegurar la vía aérea superior y la adrenalina representa la base del tratamiento. Todos los casos con afectación laríngea deben de ser considerados una urgencia médica, y si hay signos de compromiso importante de la vía aérea se debe valorar la intubación.

En cuanto a la adrenalina, a pesar de no ser un tratamiento indicado para la urticaria aguda, ante episodios de sospecha de anafilaxia que podrían iniciarse con urticaria, estaría indicado su uso. La dosis (ampollas de dilución 1:1000) es de 0.3-0.5 ml administradas por vía intramuscular en la cara lateral externa del mus-lo, que puede repetirse cada 5-15 minutos según sea necesario hasta una dosis máxima de 1.5 ml.

A modo de resumen, los pilares en el tratamiento de la urticaria y el angioedema son las medidas generales (evitación de desencadenantes) y como tratamiento farmacológico en la fase aguda los antihistamínicos y los glucocorticoides.

Antihistamínicos

En la urticaria aguda se administran por vía sistémica en el Servicio de Urgencias y posteriormente se prescriben domiciliariamente de forma continua hasta que el paciente se encuentre al menos 7-10 días libre de síntomas. De esta forma se disminuye el riesgo de recidivas o la cronificación.

Los antagonistas de receptores H1 controlan por lo general la mayoría de los casos de urticaria y el prurito. Los de primera línea terapéutica de elección son los anti-H1 de segunda generación no sedante como la loratadina (10-20 mg/día), la desloratadina (5 mg/día) o la fexofenadina (120-180 mg/día). También son muy utilizados otros con poca capacidad sedante como la cetirizina (10 mg/día) o la levocetirizina (5mg/día). Otros antagonistas de receptores H1 utilizados, aunque con mayor capacidad sedativa, son la clorfeniramina o la difenhidramina.

En el caso de que no haya mejoría con estas dosis, la recomendación es incrementar la dosis hasta un máximo que se establece en el cuádruplo de la dosis estándar. Se debe esperar entre 1-4 semanas para comprobar la efectividad.

Si aún así resultan ineficaces en el control de los síntomas, se puede añadir un antagonista de receptores H2 como la cimetidina, la ranitidina o la famotidina.

Otra posibilidad es utilizar la doxepina, un antidepresivo tricíclico que posee actividad antagonista de los receptores H1 y H2. Es útil sobre todo en casos de urticaria intensa acompañada de síntomas afectivos.

En los casos de urticaria crónica, el problema es que el cese de estos tratamientos suele originar una recidiva. En este caso o en caso de ineficacia se podría utilizar la ciproheptadina en dosis iniciales de 8 mg, que se aumentan hasta llegar a 32 mg/día y en particular la hidroxizina con dosis iniciales de 40 mg que se aumentan hasta llegar a 200 mg/día.

Glucocorticoides

Los glucocorticoides tópicos no tienen utilidad en la urticaria (con la posible excepción de la urticaria por presión en las plantas de los pies como terapia alternativa con escasa evidencia). Es preferible no administrar aquellos de presentación sistémica en urticarias idiopáticas, inducidas por alérgenos o urticarias físicas para evitar sus efectos secundarios a largo plazo.

Los glucocorticoides de acción general se utilizan en las urticarias agudas con angioedema, en las urticarias por presión o vasculíticas (en particular con participación de eosinófilos), en el angioedema idiopático con o sin urticaria o en la urticaria crónica que no mejora con el tratamiento habitual.

Existe una fuerte recomendación contra el uso a largo plazo de corticoesteroides. Se aconseja su uso en ciclos cortos y pautas descendentes, normalmente prednisona a dosis de 0.5 mg/kg/día, aunque no está establecida una dosis determinada.

En el caso de episodios agudos intensos o exacerbaciones graves de urticaria crónica (especialmente cuando se acompaña de angioedema) se suele indicar un ciclo corto de corticoesteroides orales (prednisona a dosis de 30-60 mg/día en pauta descendente durante hasta un máximo de 10 días). Con esto se reduce la duración y la actividad de la enfermedad.

Otros fármacos

Pueden utilizarse ante la refractariedad con los anteriores y ya no en el momento urgente son los siguientes:

Omalizumab: Es un Ac monoclonal contra IgE. Se recomienda la agregación a los antihistamínicos en los pacientes con urticaria crónica que no responden a antihistamínicos H1 de segunda generación. Ha demostrado ser muy eficaz y seguro en el tratamiento de la urticaria espontánea. Previene el desarrollo de angioedema, mejora notablemente la calidad de vida y es adecuado para el tratamiento a largo plazo. La dosis establecida es de 150-300 mg cada 4 semanas (siendo la dosificación independiente de la IgE sérica total). También es eficaz en la urticaria inducida (urticaria solar, urticaria por frío, urticaria colinérgica...).

Ciclosporina A: No está autorizada para la urticaria y se recomienda solo para pacientes con enfermedad grave (urticaria idiopática crónica o autoinmunitaria crónica intensa) resistente a cualquier dosis de antihistamínico y omalizumab en combinación o si éstos están contraindicados o no recomendados por los efectos adversos. No se puede recomendar como tratamiento estándar debido a una alta incidencia de efectos adversos.

Montelukast: Es un antagonista del receptor de leucotrienos CysLT1. Se podría agregar al tratamiento con antihistamínicos en dosis de 10 mg/día. De todos modos, el nivel de evidencia de la eficacia de los antagonistas de los receptores de leucotrienos en la urticaria es bajo.

Antagonistas de TNF-alfa e Ig IV: Los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa y las Ig IV

se recomiendan actualmente solo como última opción (el anti TNF-alfa para urticaria por presión retardada y las Ig IV para la urticaria crónica espontánea).

BIBLIOGRAFÍA

- Zuberbier T, Aberer W, Asero R, et al. The EAACI/GALEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. Allergy. 2018.
- Hospital Universitario 12 de Octubre. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 8a ed. Madrid; 2016
- Wolff K, Johnson R, Saavedra A. Fitzpatrick. Atlas de Dermatología clínica. 7a ed. México: Mc Graw Hill; 2014.